أعراض الأمراض الغدية

1 د. رنا شنات

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

16/09/2024

RBC Medicine

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة الأولى من مادة المهارات السريرية والأولى في قسم الغدّيّة، مستعرضين فيها لمحة عامة عن الفحص السريري الغدّي والأمراض والأعراض الغدّيّة

ونرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل



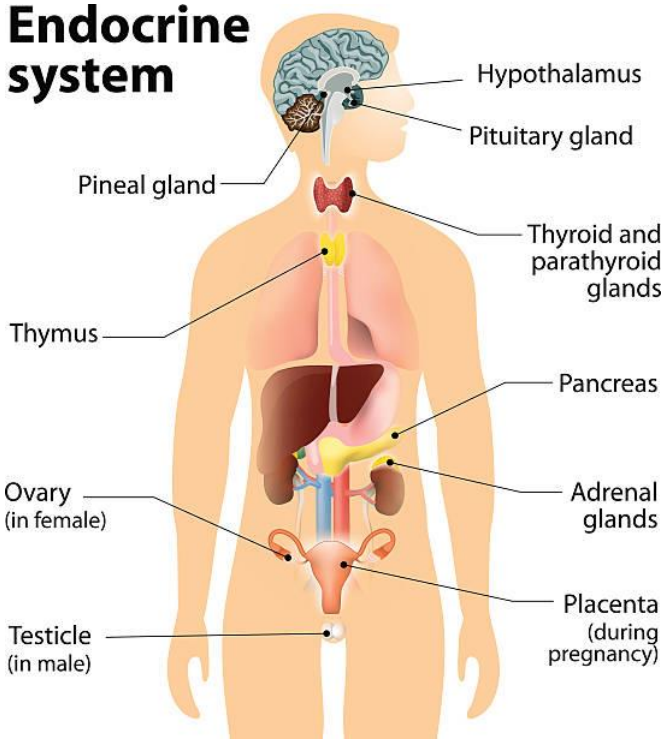
لمحة عن الجهاز الغدي

- هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء (الغدد) الصغيرة الموزعة في الجسم، كما يُعدّ هذا الجهاز **المجموعة الناظمة** لكل أجهزة الجسم الأخرى.
- تتميّز هذه الغدد بأنّها على درجة عالية من **التخصص** (أي لكل منها عمل نوعي خاص بها إذ تحتوي على **حبيبات إفرازية** مسؤولة عن بعض الإفرازات من هرمونات وعصارات هاضمة بالإضافة لإفرازات الغدد اللعابية والدهنية..).

أهم الغدد الصم

	الموقع	الوظيفة
الغدة النخامية (الغدة السيدة)	في قاعدة الدماغ	• تنظم عمل باقي الغدد، تفرز هرمون النمو. • الخلل فيها يتمثل بطول وقصر القامة بشكل رئيسي.
الغدة الدرقية	في مقدمة العنق	• مسؤولة عن الاستقلاب. • الاضطراب فيها يتمثل بخلل استقلابي في الجسم.
الغدد جارات الدرق	على الوجه الخلفي للغدة الدرقية	• مسؤولة عن استتباب تركيز الكالسيوم والفوسفات في الدم. • الخلل فيها يؤدي إلى اضطراب هذه الشوارد وتركيزها.
الغدة الكظرية	القلنسوة التي تغطي الكلية	• تتكون من قشر ولب يختلفان عن بعضهما بالمنشأ الجنيني.
المعثكلة (البنكرياس)	على الجدار الخلفي للبطن	• غدة مزدوجة الإفراز، مسؤولة عن إفراز الأنسولين والغلوكاغون. • الاضطراب فيه يتجسد بخلل في عملية استقلاب السكر.
الأقناد	تضم الخصية عند الذكر والمبيض عند الأنثى	• مسؤولة عن كلٍّ من: انتظام الدورة الطمثية، القدرة الإنجابية وظهور الصفات الجنسية الثانوية. • أيّ مشكلة فيها قد تتجسّد بغياب الصفات الجنسية الثانوية.





الاستجواب

الهوية الشخصية

الهوية الشخصية تشمل

- الاسم
- العمر
- الجنس
- السكن
- العمل

1. الاسم:

- يفيد معرفة اسم المريض **الكامل** في تمييز ملفات المرضى ذوي **الأسماء المتشابهة**.
- والأهم من ذلك أن اسم العائلة يفيد في معرفة الأمراض الوراثية الموجودة في هذه العائلة، ففي كثير من الأحيان ترتبط **الأمراض الوراثية** بأسماء **عائلات معينة**.

2. العمر:

- يوجه العمر نحو التشخيص السليم، لأن بعض الأمراض تصيب **فئة عمرية معيّنة** دون أخرى (مثلاً مرض يصيب الأطفال دون الكبار وآخر يصيب المسنين غالباً).

↵ ومع ذلك **يجب أخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار**؛ إذ يمكن للمرض أن يصيب أفراداً خارج الفئة العمرية المعتادة وذلك في حالات جديدة.

3. الجنس:

- معرفته مهمة جداً في الأفراد المحتمل إصابتهم **بأمراض مرتبطة بالجنس**، وذلك لأن بعض الأسماء تستخدم للجنسين فلا نستطيع تمييز ملف المريض أهو لذكر أم لأنثى.

4. السكن:

- يجب معرفته بسبب وجود بعض الأمراض المنتشرة في **مناطق جغرافية محددة** دون أخرى.
  - كالتلاسيميا التي تنتشر في جنوب سوريا.

5. العمل:

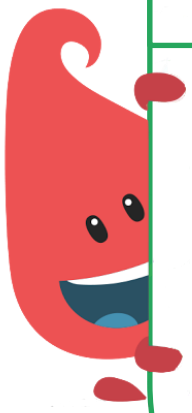
- مفيد للتشخيص لأن بعض المهن تؤثر بشكل مباشر على الجسم، وكثيراً ما تكون مهنة الشخص هي **السبب الرئيسي** في العلل التي يشكو منها.
  - **على سبيل المثال**: قد تكون الأعمال القاسية للأطفال سبباً في تأخر نموّهم.

الشكاية الرئيسية Chief Complaint

- السبب الذي دفع المريض للقدوم إلى الطبيب، رمزها: (ش.ر).
- نسأل فيها عن الأمور التالية:

زمن بدء الأعراض ← المرافقات ← تطور الأعراض وتواترها (يفيد معرفة التواتر في الأمراض التي تأتي على شكل نوبات) ← العوامل المخففة والمشددة

مثال عملي



أتى مريض بشكوى رئيسية هي البدانة، فنسأله عن:

1. **زمن البدء وتطور البدانة:** حادة مفاجئة (خلال أيام) أم مزمنة تدريجية (خلال أشهر).
2. **المرافقات:** إمساك، أو إسهال، أو صداع، أو فرط شهية (أغلب مرضى البدانة لا يدركون أنهم يعانون فرط شهية إلا بعد استشارة الطبيب).
3. **العوامل المخففة أو المشددة:** يندرج ضمنها الحميات الغذائية، والحركة، والعوامل النفسية، أو الحوادث مثل كسر في ساق المريض؛ فأقعده في المنزل لشهرين مما أدى لزيادة ملحوظة في وزنه.

التاريخ المَرَضي والسوابق الشخصية

✸ نسأل فيه عن:

1. السوابق الجراحية.

2. السوابق الدوائية:

- يجب معرفة جميع الأدوية التي تعالج بها المريض سابقاً والأدوية التي يخضع لها حالياً لِمَا لها من تأثيرات أساسية وجانبية.
  - وبشكل خاص الأدوية المحضّرة من **خلاصات الأعشاب** فغالباً يدخل في تركيبها **هرمونات معينة** تسبب خللاً لدى ارتفاع تراكيزها في الجسم.

في سوريا مثلاً وجدت مادة السلفونيل يوريا (خافض سكر يسبب فتح الشهية والشعور بالجوع) في أحد المستحضرات الشائعة ويروّج لها على أنها خلاصة أعشاب صينية تساعد على اكتساب الوزن للمرضى الذين يعانون من النحول الشديد.

3. السوابق التحسسية:

- من المهم دائماً معرفة الأدوية التي يعاني المريض من **حساسية** تجاهها وتدوين ذلك في ملفه.

4. السوابق العائلية:

- تشمل السوابق العائلية كل من السوابق **المَرَضية** و**العلاجية** للعائلة.
  - قد تشير القصة العائلية إلى وجود مرض درقي أو داء سكري أو متلازمة الأورام الغدية.
  - قد تدل كذلك على بعض الأمراض النادرة التي تورّث بطريقة **قاهرة** مثل أورام النخامة، أورام الدرق اللبية، فرط نشاط جارات الدرق، أورام القواتم وأورام البنكرياس.

يجب على الطبيب فيما يتعلق بعائلة المريض أن:

- يعرف درجة القرابة بين مريضه والأفراد المصابين بأمراض وراثية في عائلته.
- يستفهم من المريض على كل ما يعدّه ضرورياً للتوصل إلى التشخيص الصحيح.
- يفهم طبيعة المريض الذي يتعامل معه، فبعض المرضى يسرّون لكثرة أسئلة الطبيب وتناوله تاريخ أفراد عائلته مرضياً وعلاجياً ويرونها دليلاً على نباهة الطبيب ودقة تفكيره، بينما بعضهم الآخر يرونها مصدر إزعاج وتدخلاً لا داعي له ولا علاقة له بالطب، وعندها يجب على الطبيب توضيح أهمية الاستجواب الدقيق في التوصل للتشخيص والعلاج المناسب.

5. القصة الاجتماعية:

- كثير من الأمراض الغدية **مزمنة** ولها اختلاطات عديدة.

↳ لذا فإن نجاح علاج هذه الامراض يعتمد في كثير من الأحيان على مدى تكيف المريض مع هذه الأمراض المزمنة علماً بأن دعم البيئة المحيطة بالمريض هو **عامل أساسي** في تكيف المريض مع مرضه.

بعض الحالات المرتبطة بالسوابق الشخصية للمريض:

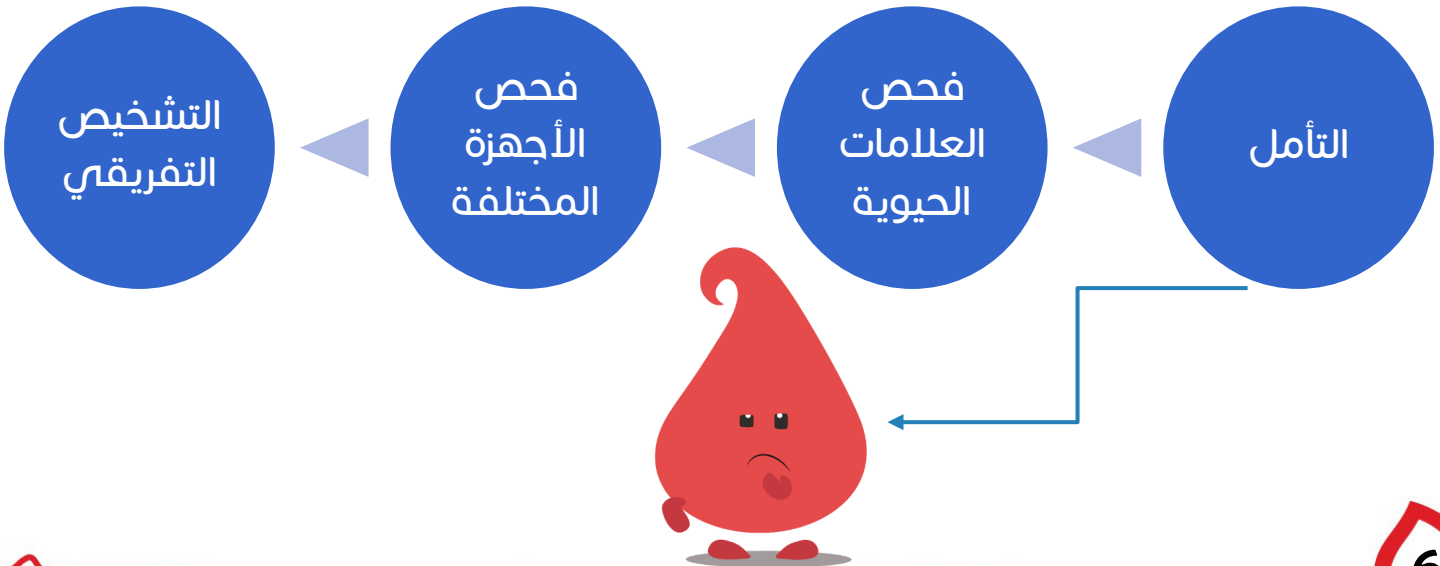
- **استئصال الدرق**: الكلي أو الجزئي الجراحي أو الشعاعي قد يؤدي إلى قصور درق.
- **مريض بدانة**: يشكو من كسل وتعب وخمول ذهني يلاحظه الطبيب أثناء الاستجواب بالإضافة لشعور دائم بالبرد، عندها يجب سؤال المريض عن **استئصال الدرق** لأن أعراض المريض توجه إلى بدانة درقية.
  ↳ عدم تحمّل البرد والتعب والكسل من أعراض نقص نشاط الدرق أيضاً.
- **قصة ولادة جنين كبير الحجم**: قد توحي بوجود داء سكري عند الأم.
- **قصة جراحة في النخامى أو الكظر**: قد تؤدي لقصور لاحق فيهما.
- **تجريف الرحم**: قد يؤدي لانقطاع تام للطمث إن كان **التجريف جائراً** (أي تم تجريف بطانة الرحم كاملة).

استئصال الدرق الشعاعي:

RBO Clinical

- يتم استئصال الدرق الشعاعي عبر إعطاء جرعات مكثفة من نظير اليود المشع لخلايا الغدة الدرقية فينتج عن الإشعاع قتل الخلايا المعرضة له دون إلحاق أذيات ببقية أعضاء الجسم.
- نلجأ للاستئصال الشعاعي كبديل للتدخل الجراحي في حالات فرط نشاط الدرق مع أعراض تسممية، وأورام خبيثة.

الفحص السريري الغدي Endocrine Examination



1. التأمل:

❖ **المظاهر العامة**: يبدأ الفحص السريري منذ دخول المريض، إذ يمكن تمييز العديد من العلامات مثل:

الاضطرابات الجلدية	سحنة المريض	الشحوب والتصبغات	توزع الأشعار

❖ تتظاهر الكثير من الأمراض **بعلامات واضحة جداً** مثلاً:

- **مريض فرط نشاط الدرق**: متوتر بشكل واضح، عصبي، نظراته غير ثابتة وسريعة، يجلس على طرف الكرسي بينما يهز قدميه باستمرار.
- **بدانة قصور الدرق**: بدانة **معممة** (أي يوجد بدانة في مختلف أنحاء الجسم وليست بدانة في منطقة معينة) مع جلد متوذم مع منظر جاف للجلد، ويختلف لون الجلد عن الطبيعي بدرجات خفيفة تميزه العين الخبيرة.
- **البدانة الطعامية**: بدانة **معممة** دون توذم.
- **بدانة فرط الكورتيزول**: بدانة **جذعية** (مركزية)، وتبقى الأطراف نحيلة.

2. فحص العلامات الحيوية:

❖ مثل قياس معدل ضربات القلب (قياس النبض) ودرجة حرارة الجسم ومعدل التنفس وضغط الدم.

❖ العلامات الحيوية **هامة جداً** ويجب فحصها **دائماً**.

3. فحص الأجهزة المختلفة.

4. التشخيص التفريقي:

❖ من المهم التمييز بين الأمراض التي تناسب أعراض المريض واختيار **الأنسب** لحالته منها.

القصة الغدّية The Endocrine History

❁ إن أعراض أمراض الغدد الصم واسعة جداً بسبب سيطرة الهرمونات على وظائف متعددة في الجسم البشري.

❁ كما أن العديد من الأعراض لها أسباب أخرى **غير غدية** وبالتالي يجب تقييمها بدقة.

❁ أعراض أمراض الغدة **العامة** يتم عن طريقها تحديد المرض **الأساسي**، هي:

سعال	إسهال	تغيرات الشهية

الأعراض الرئيسية للأمراض الغدّية

أولاً: تغيرات الوزن والشهية Appetite:

✸ نميز فيه أربع حالات:

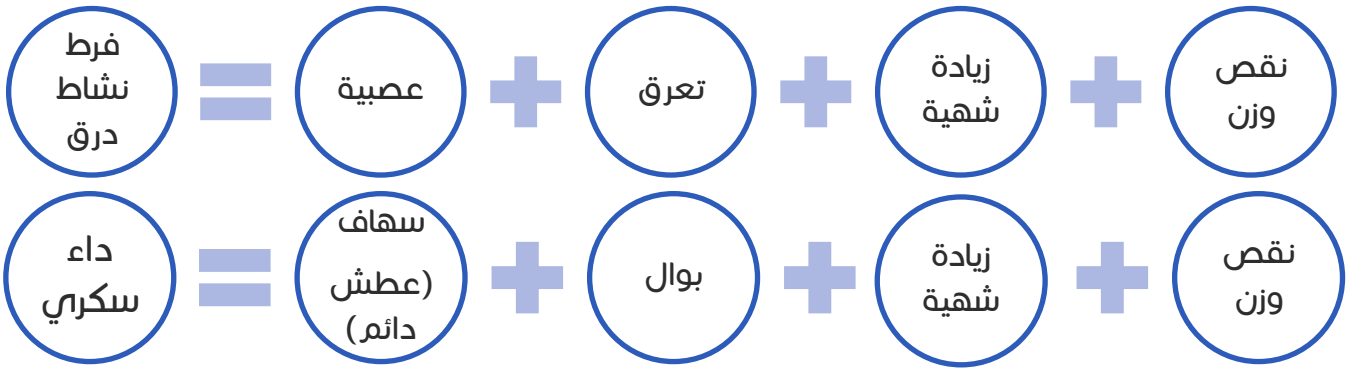
1. نقصان الوزن المترافق مع زيادة الشهية:

- يشير إلى فرط نشاط الدرق والداء السكري، يفسّر ذلك بـ:

➤ **فرط نشاط الدرق**: يحدث نقصان الوزن بسبب ازدياد الفعاليات الاستقلابية في الجسم.

➤ **الداء السكري**: تتراجع الاستفادة من الغلوكوز بسبب عوز الأنسولين مما يجعل الخلايا متعطشة للطاقة فتزداد الشهية مع نقصان الوزن.

↙ كيف نميز بين هذين المرضين المترافقين مع نقصان في الوزن وازدياد الشهية؟



2. نقصان الوزن المترافق مع نقصان الشهية:

- يشاهد في قصور قشر الكظر بسبب نقص الكورتيزول (هرمون الكورتيزول يُفرز من قشر الكظر ويزيد الشهية)، والقَهَم أو القهم العصبي، وفي كثير من أمراض جهاز الهضم ولا سيما الخباثات.

القهم العصبي: (إثراء) RBO Enriching

- هو مرض **نفسي جسدي** يتصف بالاضطراب في الأكل والانخفاض الشديد في وزن الجسم مع الخوف من زيادة الوزن لذلك فهو غالباً يصيب الفتيات اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية بسبب الوزن الزائد.
- وبما أن مراكز الجوع متوضعة في الوطاء فتؤدي الإصابة بالقهم العصبي إلى اضطراب واسع الانتشار في الغدد الصم (على نطاق الغدة النخامية والغدد التناسلية) إذ يظهر في الأنثى على شكل انقطاع الطمث وقد تكون هناك مستويات مرتفعة من هرمون النمو ومن هرمون الكورتيزول وتغيرات في الاستقلاب واختلالات في الأنسولين.
- نسبة الوفاة قد تصل لـ10٪ عند رفض العلاج.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

3. زيادة الوزن المترافقة مع زيادة الشهية:



- تشاهد في:
  - **متلازمة كوشينغ**: يحدث فيها فرط **الكورتيزول**.
  - **نقص سكر الدم**: إذ يعد السكر مصدر الطاقة **الرئيسي** للدماغ، فنقصانه يسبب اضطرابات في التحكم بمراكز الجوع والعطش وبالتالي ازدياد الشهية وازدياد الوزن.
  - **مرض مهادي**: إذ توجد مراكز الشهية في الوطاء، فأي اضطراب عصبي من تحت المهاد (خاصة الوطاء) سيؤدي إلى زيادة الوزن والشهية معاً.

نشاهد في الصورة المجاورة مريض مصاب بمتلازمة كوشينغ

4. زيادة الوزن المترافقة مع نقصان الشهية:

- تشاهد في قصور الدرق بسبب انخفاض معدل الاستقلاب العام في الجسم، وتراكم عديدات السكريد المخاطية؛ مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ثانياً: تغيرات في عادات التغوط Bowel Habit:

1. الإسهال Diarrhea:

- يكون عَرَضاً لـ:
  - **فرط نشاط الدرق**: لأنه يسبب **زيادة** حركية الأمعاء.
  - **قصور قشر الكظر**: إن هرمون الكورتيزول **يزيد** من حساسية مستقبلات الأمعاء للكاتيكولامينات التي **تثبط** حركية الأمعاء، وبالتالي فإن **عوز** هرمون **الكورتيزول** بسبب قصور قشر الكظر يسبب ← **نقص الحساسية للكاتيكولامينات** ← **ازدياد حركية الأمعاء**.

2. الإمساك Constipation:

- يكون عرضاً لـ:
  - **قصور الدرق**: بسبب **انخفاض** حركية الأمعاء.
  - **فرط كلس الدم**: إذ **يزداد** تركيز الكالسيوم في الدم بسبب فرط نشاط **جارات الدرق**، ومن أعراض **ازدياده تباطؤ** في تقبض عضلات الطبقة الخارجية للأمعاء.

ثالثاً: تغيرات التعرّق Sweating:

- يكون ازدياد التعرق من أعراض:
  - **فرط نشاط الدرق**: بسبب **زيادة** كل الفعاليات الاستقلابية في الجسم وبالتالي ارتفاع الحرارة والتعرق.
  - **ورم القواتم**: إذ **يفرز** هذا الورم الكاتيكولامينات، ومن أعراض زيادة إفراز الكاتيكولامينات ازدياد التعرق.
  - **نقص سكر الدم**: إذ يحدث **فرط** الأنسولين ← **فرط** إدخال الغلوكوز إلى الخلايا ← **فرط** الفعاليات الاستقلابية للاستفادة من الغلوكوز إما بخزنه أو حرقه وبالتالي ازدياد التعرق.
  - **ضخامة النهايات**: تحدث بسبب **فرط** إفراز هرمون النمو بعد البلوغ ← **تتضخم** الغدد الدرقية ويزداد التعرق.
  - **سن الإياس**: تعاني النساء في سن الـ 45 من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة (هبّات ساخنة) ترافقها نوبات من التعرق.

رابعاً: تغيرات في توزع الأشعار:

1. الشعرانية Hirsutisum:

- زيادة في نمو أشعار الجسم عند النساء، وتكون من أعراض:
  - **خلل في المبيض أو قشر الكظر** مما يؤدي إلى **زيادة** الأندروجينات (الهرمونات التي تحفز نمو الشعر).
  - **تأثيرات جانبية** لبعض الأدوية الهرمونية (دانازول – ستيروئيدات بانية – فينوتيئين).

2. تراجع أشعار الرأس في المنطقة الصدغية عند النساء:

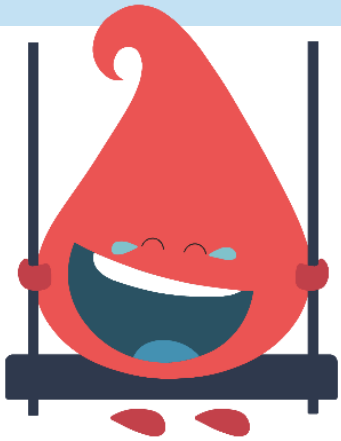
- يشير إلى زيادة الهرمونات الذكرية الكظرية.

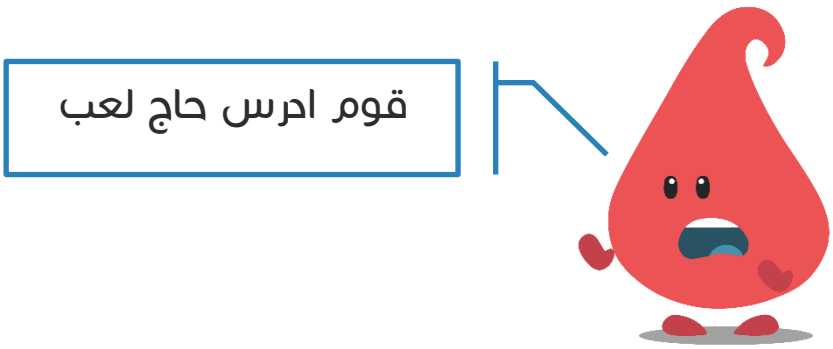
3. غياب أشعار العانة والإبط عند الجنسين:

- يشير إلى نقص الهرمونات الذكرية الكظرية.

4. غياب أشعار الوجه عند الجنسين:

- قد يشير إلى وجود قصور الأقناد.





خامساً: تغيرات الجلد:

1. الجلد جاف Dry، وخشنRough، وشاحب Pale:

- من أعراض **قصور الدرق** بسبب تراكم عديدات السكريد المخاطية.

2. الجلد جاف وحرشفي Scaly Skin:

- من أعراض **فرط الدريقات** (جارات الدرق) بسبب فرط الكالسيوم.

3. تبيّغ الجلد واحمراره Flushing Skin:

- يُرى في الرأس والعنق، وهو من أعراض **متلازمة الكارسينويد**.

4. طغوات جلدية Skin Tags في الإبط والوجه:

- من أعراض **ضخامة النهايات** (ضخامة الأطراف) إذ تحدث زيادة نمو الأنسجة الرخوة.

5. الشواك الأسود Acanthosis Nigricans:

- حالة يتميز فيها الجلد باللون الداكن ويزداد سمكه خصوصاً في طيات الجسم.
- الشواك الأسود من أعراض:
  - **ضخامة النهايات**، ومتلازمة **زيادة المقاومة للأنسولين** المرافقة للمبيض متعدد الكيسات و**كوشينغ**.
  - حالة الشواك الأسود ممكن أن تترافق مع **سكري** مستقبلاً.

متلازمة الكارسينويد (المتلازمة السرطاوية) Carcinoid Syndrome: RBC Clinical

- هي نوع من السرطان البطيء النمو يمكن أن ينشأ في عدة أماكن من الجسم وعادة ما ينشأ من الخلايا المعوية الأليفة الكرومية في جميع أنحاء الأمعاء.
- غالباً ما تظهر أعراضه متأخرة حيث يمكن أن ينتج كميات كبيرة من الهرمونات (أشيعها السيروتونين) تسبب أعراض مثل الإسهال والتوهج الجلدي وخفقان القلب وتوسع شرينات ووذمة في الساقين....



الجلد الحرشفي



الشواك الأسود



الطغوات الجلدية



تبيغ الجلد

سادساً: تغيرات التصبغ Pigmentation:

1. زيادة التصبغ:

- تُشاهد في:

➤ **قصور قشر الكظر الأولي (داء أديسون)**: إذ يؤثر انخفاض تركيز الكورتيزول في الدم على النخامى بآلية **تلقيم راجع سلبي**، مما يزيد من إفراز ACTH الذي يسبب زيادة التصبغ لأنه يترافق بإفراز MSH (الهرمون المنبه للخلايا الميلانينية في الجلد Melanin Stimulating Hormone).

➤ **متلازمة كوشينغ Cushing's syndrome**: وهي متلازمة فرط نشاط قشر الكظر.

↵ يزداد إفراز الكورتيزول نتيجة زيادة إفراز ACTH من النخامى الأمامية، فنلاحظ وجه المريض بلون أحمر بدري Moon-Shaped Face مع وجود تشققات أرجوانية اللون على بطنه، وذراعيه وساقيه.

➤ **ضخامة النهايات**.

2. نقص التصبغ:

- يُشاهد في **قصور النخامى** بسبب نقص إفراز MSH.

3. البهاق أو البهق:

- هو **مناطق** من نقص التصبغ يشاهد في:

➤ **داء هاشيموتو Hashimoto's Disease**: وهو مرض مناعي ذاتي يصيب الغدة الدرقية، يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد في مناطق معينة.

➤ **داء أديسون Addison's disease**: يسبب زيادة تصبغ في أغلب مناطق الجسم (كما ذُكر قبل قليل) لكن ذلك لا ينفي تخلل بقع بهاقية فاتحة للتصبغات الغامقة.

EXTRA

ملاحظة

غالبًا ما تترافق الأمراض المناعية الذاتية مع بعضها، فوجود أحدها يدفعنا للتفكير بوجود مرض مناعي ذاتي آخر أو أكثر، إذ تنجم الأمراض المناعية الذاتية عن تشكل أضداد بالجسم تهاجم الغدة؛ فتسبب نقصًا في إفرازها، وقد لا تقتصر على هذه الغدة بل تتعداها لغدد وأماكن أخرى بالجسم كداء أديسون الذي يسبب البهاق أيضًا علمًا أن الدائين مناعيين ذاتيين



متلازمة كوشينغ



زيادة التصبغ



البهق

سابعاً: تغيرات القامة والطول Stature:

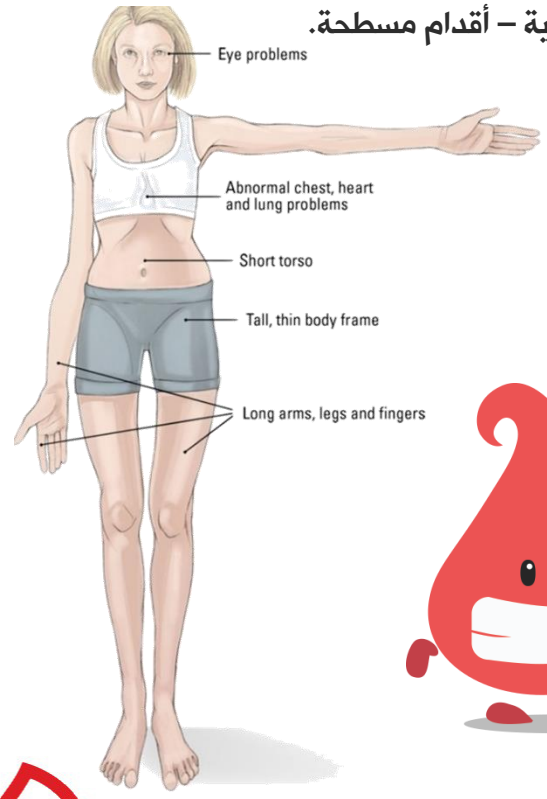
1. قصر الطول:

- ينتج عن:
  - **سوء التغذية أو سوء الامتصاص.**
  - **أسباب بنيوية (عائلية) وراثية.**
  - **أسباب غدية**: مثل عوز هرمون النمو أو قصور الدرق أو قشر الكظر.

2. زيادة الطول:

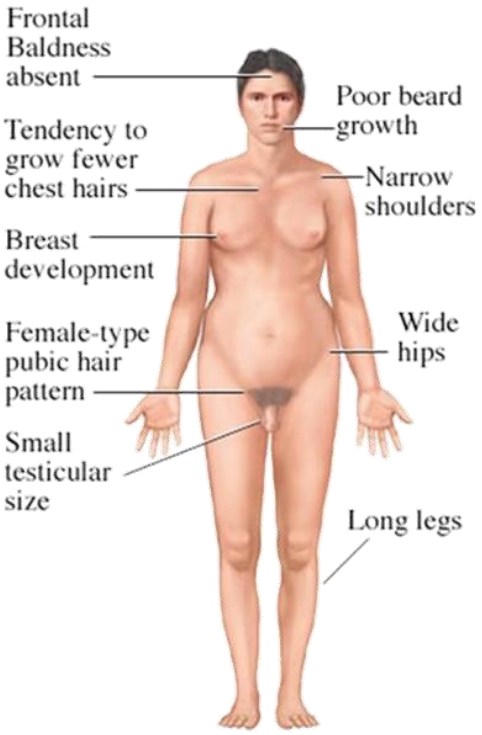
- تنتج عن:
  - **أسباب بنيوية وراثية**: ككون الأب والأم طويلين.
  - **زيادة إفراز هرمون النمو** (العملقة).
  - **قصور الأقناد**: سواء **بنقص** الهرمونات التي تفرزها أو **غيابها**، مما **يؤخر تعظم المشاشات** فيزداد نمو العظم طولاً، فكما نعلم أن **الهرمونات الجنسية** تعمل على **تسريع انغلاق المشاشات** ليكتمل البلوغ.
  - **متلازمة كلينفلتر**: تناذر خلقي وراثي يؤدي إلى **قصور الأقناد**.
  - **متلازمة مارفان**: يلاحظ فيها ازدياد الطول مع قصور قلبي.

↵ **أعراضها:** مشاكل عينية - هيكل طويل ونحيف – طول الذراعين والساقين والأصابع بطريقة غير متسقة – بروز عظم الصدر إلى الخارج أو انغماسه إلى الداخل – نفخات قلبية – أقدام مسطحة.





توضّح الصورة إلى اليمين متلازمة كلاينفلتر والصورة إلى اليسار متلازمة مارفان



ثامناً: العنانة Impotence:

- هي ضعف القدرة الجنسية عند الذكور، وتعد العنانة من أعراض:
  - **قصور الأقناد، اضطرابات نفسية.**
  - **اعتلال عصبي** (سكري أو كحولي) أو **مرض في النخاع الشوكي** يؤدي إلى خلل بتعصيب الأعضاء التناسلية.

تاسعاً: تغيرات الطمث Menstruation:

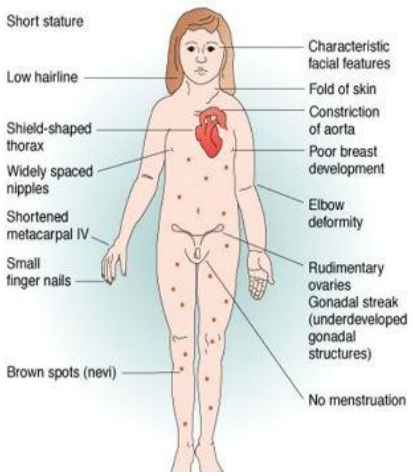
- الضهي Amenorrhea هو عدم حدوث الطمث، ويكون:

1. ضهي أولي:

- هو **عدم حدوث الطمث** رغم وصول الأنثى إلى سن الخامسة عشر من عمرها.
- ينتج عن:
  - **قصور المبيض**: كما يحدث في متلازمة **تيرنر**، أو في مرض **مهادي** أو **نخامي** يؤثر على إفراز FSH-LH، كما يحدث في **الأورام**.
  - **زيادة الأندروجين.**
  - **أمراض جهازية**: مثل سوء الامتصاص والقصور الكلوي، فالأمراض الجهازية قد تتعمم إلى مناطق أخرى في الجسم (قد تتعمم إلى النخامى عبر الدم مثلاً).
  - **انسداد في الطرق التناسلية**: كما في حالة غشاء البكارة غير المثقوب؛ عندها يجب اللجوء إلى **العمل الجراحي**، لكن بعد **نفي جميع الأسباب الأخرى الفيزيولوجية** المسببة لانقطاع الطمث.

متلازمة تيرنر: RBO Clinical

- خلل في الصيغة الصبغية حيث تكون XO بدلاً من XX السوية.
- تتظاهر المتلازمة **بقصر القامة وانقطاع الطمث وعدم ظهور الصفات الجنسية الثانوية.**
- الصفات المفضّلة لمريضة متلازمة تيرنر:
  - قصر في القامة، انخفاض شعر الرأس، الرقبة مكفكفة، عيوب قلبية، صغر الثديين، الصدر عريض (درعي)، انحراف الذراع إلى الخارج، ضمور المبيض، تأخر الدورة الشهرية، قصر في العظم السنعي الرابع لليد، أظافر مقوسة، شامات بنية صغيرة.
- من الضروري أن نجري لهنّ **تخطيط القلب.**



2. ضهي ثانوي:

- توقف الطمث لمدة تتجاوز 6 أشهر، من أسبابه:

المبيض متعدد الكيسات	متلازمات الاسترجال	سن الإياس	الحمل
استعمال حبوب منع الحمل	أمراض نفسية	أمراض النخامة والمهاد	فرط بروالاكتين الدم

- ميزاته الرئيسية:
  - **السمنة واللاإباضة** (سبب الضهي الثانوي) والكميات المفرطة من الأندروجينات.
  - **مقاومة الأنسولين**: مما يؤدي إلى ارتفاع الغلوكوز في الدم وبالتالي السكري (أي أن الإناث المصابات بالمبيض متعدد الكيسات مؤهلات للإصابة بالسكري).
  - **شواك أسود**: ينتشر في مؤخرة العنق والإبطين وتحت الثديين (الشواك من علامات مقاومة الجسم للأنسولين).





ملاحظة

المبيض متعدد الكيسات من أشيع أسباب اضطرابات الغدد الصماء عند الإناث

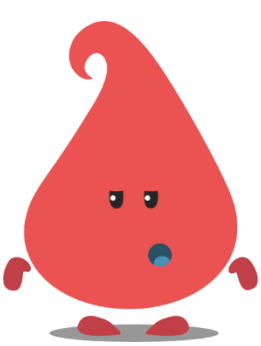
عاشراً: البوال Polyuria:

- تجاوز حجم البول لـ 3 لترات في اليوم، وهو من أعراض:
  - **الداء السكري Diabetes mellitus**: بسبب إدرار حلولي ناجم عن زيادة طرح الغلوكوز.
  - **البيلة التفهة Diabetes insipidus**: الناتجة عن نقص الهرمون المضاد للإبالة أو مقاومة الأنابيب الكلوية لهذا الهرمون.
  - **العطاش الأولي Primary Polydipsia**: شرب كميات كبيرة من الماء بسبب الحالة النفسية أو مرض مهادي.
  - **فرط كالسيوم الدم Hypercalcemia**.
  - **وجود مرض كلوي كيسي أو أنبوبي خلالي**.



إحدى عشر: النوام والوسن Lethargy:

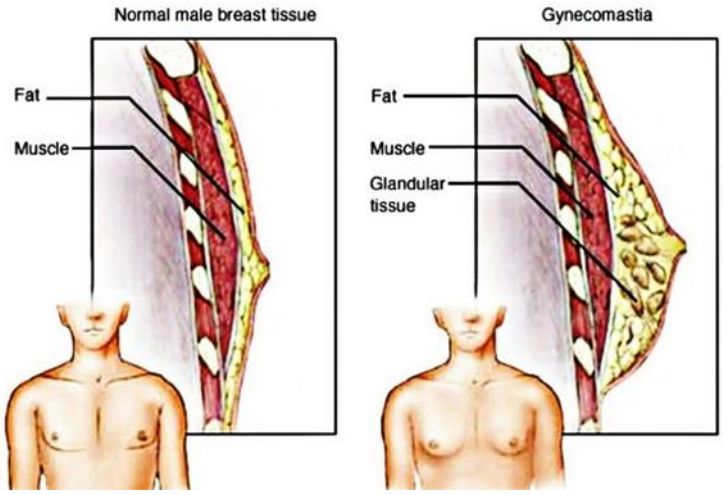
- من أعراض:
  - **قصور الدرق**: بسبب **انخفاض** معدل العمليات الاستقلابية في الجسم.
  - **قصور قشر الكظر الأولي (داء أديسون)**: يعد **الكورتيزول هرمون النوم**، فنقصه يشكّل السبب الأساسي في النعاس.
  - **قصور الكلية**: بسبب **ارتفاع تركيز البولة** في الدم، وبالتالي معاناة المريض من أعراض تعب ووهن.
  - **التهاب الكبد المزمن**:
    - التخلص من الفضلات والمواد الضارة في الجسم تعتبر من أهم الوظائف التي يقوم بها الكبد.
    - لذلك عندما تتأثر وظيفته بسبب الالتهاب المزمن سيعاني المصاب من **يرقان وتراكم الصفراء**.
    - هذا سيسبب **بولاً غامق اللون** و**براز فاتح اللون**، و**ارتفاع لانزيمات الكبد** مما يسبب التعب والنعاس.
  - **الداء السكري**: يسبب الخمول والتعب المستمر.
  - **فقر الدم وأمراض النسيج الضام**.
  - **الخباثات والإنتانات المزمنة**.
  - **الكآبة**.
  - **الأدوية المهدئة والمدرات بإحداثها اضطرابات في الشوارد**.



بعض الأمراض الغدية

التثدي Gynecomastia

- **التثدي**: هو ضخامة غدية **حميدة** في **ثدي الرجل**، ناجم عن **تكاثر غير سرطاني** في غدد الثدي.
- **سببه**: اختلال التوازن بين هرموني الإستروجين والأندروجين **لصالح الاستروجين**.
- التثدي شائع جداً في **عند اليافعين** حيث تصل نسبة حدوثه إلى 50٪ ويتراجع بعد 2 - 3 سنوات مع التقدم بالعمر، كما أنه شائع لدى **كبار السن** بسبب تراجع التستوستيرون.



ملاحظات هامة

- ❖ إنّ نقص التستوستيرون (وهو أحد الأندروجينات) يؤدّي إلى اختلال النسبة بين الإستروجين والأندروجين، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى التثدّي.
- ❖ إنّ **تراكم الشحوم** ضمن الثدي يعطي انطباعاً بالتثدّي، وهي ظاهرة تُعرف باسم "**التثدّي الكاذب** Pseudogynecomastia"، ويجب على الفاحص المتمرّس أن يميّزها عن التثدّي الحقيقي، حيث يختلف الجس للنسيج الشحمي عن النسيج الغدّي.

أسباب التثدي

أولاً: الأسباب المرضية للتثدّي:

1. ارتفاع هرمون الإستروجين:

- أورام خصوية.
- أورام مُفرزة للحاثة القندية البشرية المشيمائية HCG (في الرئة، الكبد، الخصية، الكلية).
- أمراض الكبد التي يمكن أن تؤدّي لنقص تدرّك الإستروجين.
- فرط نشاط النخامى.
- عودة الطعام بعد مخمصة[1] تسبب اضطرابات هرمونيّة.

توضيح آربسيزي إثرائي: RBO Enriching

- صحيحٌ أن HCG ينبّه الخلايا الخلاليّة في الخصيتين لإنتاج التستوستيرون، ولكن ارتفاعه يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الإستروجين بشكل غير متناسب مع إفراز التستوستيرون، فيزداد ارتفاع الإستروجين على حساب التستوستيرون.

2. قصور كلوي:

- يؤدي لعدم التوازن الهرموني.

3. فرط بروﻻكتين الدم.

4. الكحول، الهيروئين، الماريجوانا.

5. مقاومة الأندروجين:

- متلازمة التأنّث الخصوي.

[1] المخمصة هي حالة من الفقر الشديد أو الجوع (المجاعة Starvation).

6. نقص إفراز الأندروجين (اختلال النسبة بينه وبين الإستروجين):

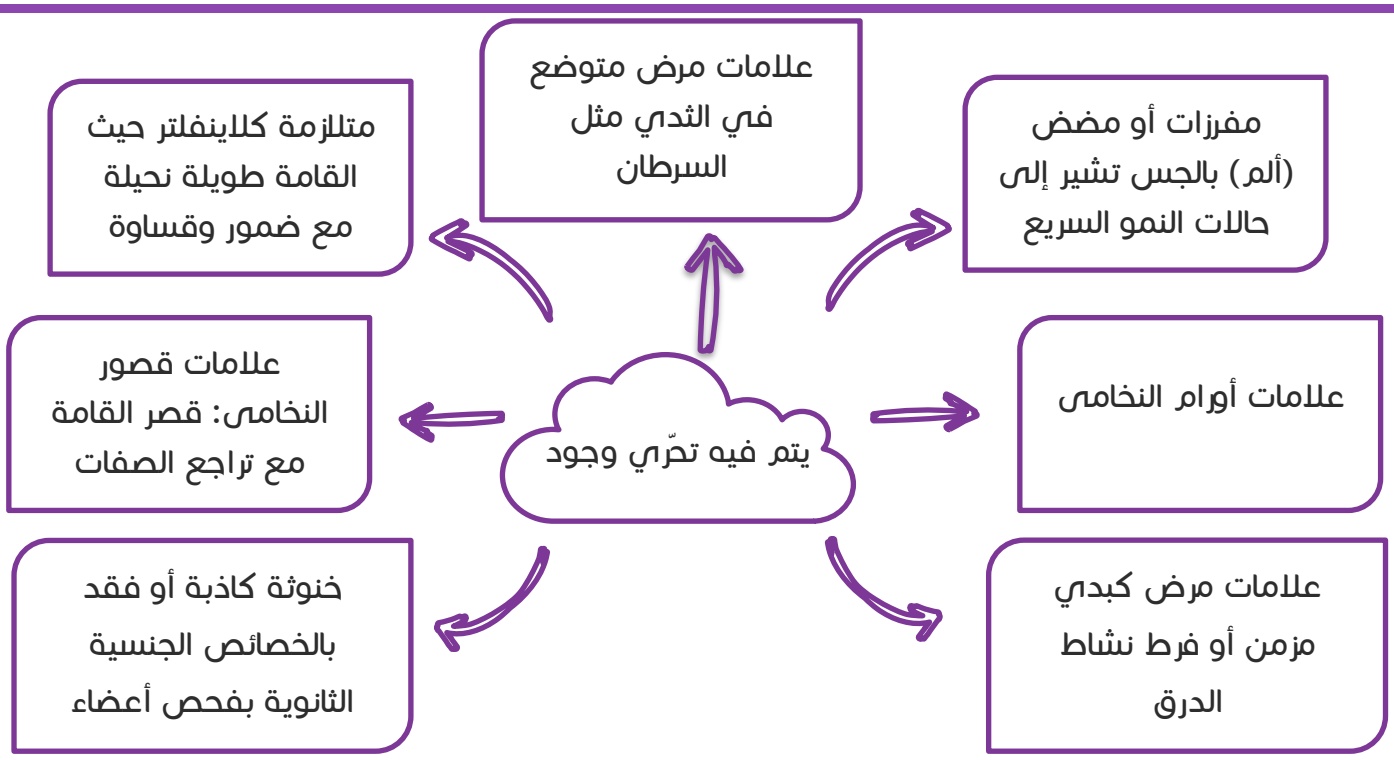
- متلازمة كلاينفلتر.
- قصور قندي ثانوي.

ثانياً: الأسباب الدوائيّة للتثدّي:

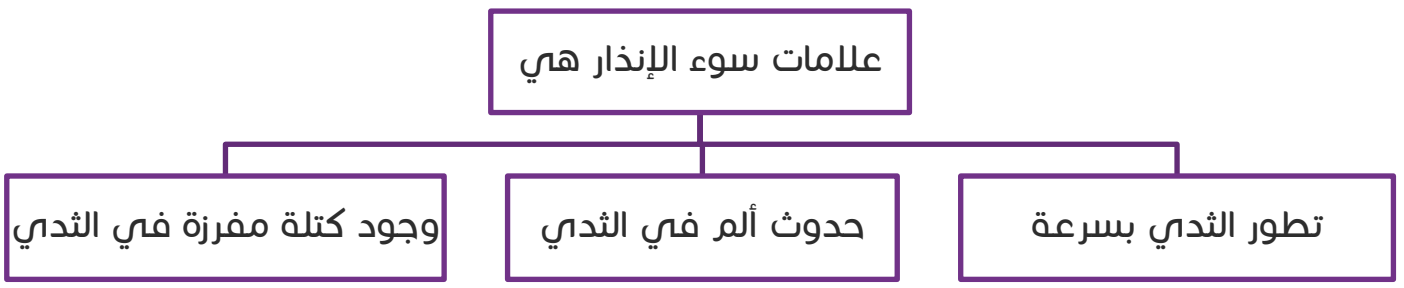
- **محرضات مستقبلات الإستروجين**: إستروجين، ديجوكسين، ستيروئيدات بانية.
- **مضادات الأندروجين**: ستيرولاكتون، سيميتيدين، سيبروتيرون.

قد يكون التثدي مجهول السبب.

فحص المريض



- تحري وجود علامات أورام النخامى يكون عبر فحص الساحة البصرية وقعر العين والعمى الشقي الصدغي المضاعف، وضمور حليمة العصب البصري.



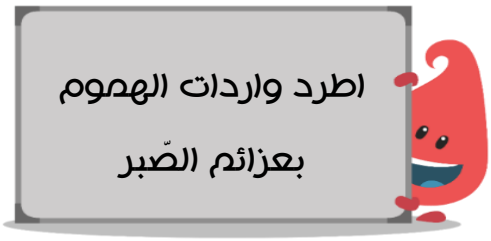
الشعرانية Hirsutism

❁ **الشعرانية**: زيادة نمو الأشعار عند النساء.

أسباب الشعرانية:

✸ **متلازمة المبيض متعدد الكيسات Polycyctic Ovarian Syndrome(PCOS)**: الأكثر شيوعاً.

✸ **أسباب كظرية**: متلازمة كوشينغ، فرط تنسج كظري ولادي، أورام كظرية مسببة للاسترجال.



✸ **الأدوية**: ستيروئيدات بانية، فينوتيئين، دانازول.

✸ **أسباب أخرى**: ضخامة النهايات، بورفرية جلدية آجلة.

✸ **أورام المبيض المسببة للاسترجال**.

الفحص والأعراض:



✸ **صلع ذكري النمط**.

✸ **أشعار** في منطقة الذقن والبطن والصدر والظهر وتحت السرة.

✸ **فحص منطقة الإبط** لتحري وجود الشواك الأسود (حالة المبيض متعدد الكيسات).

✸ **جس البطن** لكشف وجود كتل كظرية أو مبيضية.

✸ **ارتفاع التوتّر الشرياني** في حالة فرط التنسّج الولادي.

فرط التنسّج الولادي (للإطلاع): RB Clinical

- هي حالة نادرة تنجم عن عوز 11 بيتا - هيدروكسيلاز تؤدي إلى استرجال وارتفاع التوتر الشرياني.
- إنّ عوز إنزيم 11 بيتا - هيدروكسيلاز (وهو أحد الإنزيمات الضروريّة في سبيل اصطناع القشرانيّات في قشر الكظر) يؤدّي إلى زيادة كميّة المركّبات التي تسبقه في سبيل الاصطناع، من هذه المركبات "الأندروجينات" التي تؤدي إلى الاسترجال، و"الديوكسي كورتيكوستيرونات" الذي يؤدي إلى فرط التنسّج وارتفاع في الضغط الدموي.

من المهم تقرير فيما إذا كانت الشعرانية مترافقة مع **استرجال** لأن هذا يعني وجود زيادة كبيرة في إفراز **الأندروجين**.

من علامات الاسترجال



- ضمور الثدي.
- خشونة الصوت.
- ضخامة البظر.
- زيادة نمو العضل والصلع.
- ضخامة البطن.
- توزع ذكري لأشعار العانة.

الداء السكري Diabetes

- **الداء السكري**: هو ارتفاع سكر الدم الناجم عن نقص مطلق أو نسبي في الأنسولين، وقد يكون المرض غير عرضي ويكشف مصادفة بالفحوص المخبرية.
- **تحليل السكر**: يكون بعد صيام 8 ساعات عن الطعام أو بعد صيام ساعتين، حيث يسمّى **الأوّل** تحليل سكر الدم **الصيامي** بينما **الثاني** تحليل سكر الدم **العشوائي**.
  - **النسب الطبيعية**:
    - **السكر الصيامي** (70-100) ملغ/دل.
    - **السكر العشوائي** (أقل من 200) ملغ/دل (ارتفاع فيزيولوجي).
  - يعدّ المريض مصاباً بالسكري إذا كانت نسبة السكر أكبر من 126 بعد صيام 8 ساعات وأكبر من 200 بعد صيام ساعتين.
- أعراض السكري تتراوح من بوال إلى سبات ناتج عن الاحماض الخلّوني.
- اعراض السكري الرئيسية:

البوال	السُّهاف	شهية جيدة أو مزدادة	نقص الوزن	التعب والضعف

السُّهاف هو عطش شديد لا يُروى.

التصنيف السببي لداء السكري:

1. سكري نمط 1 (معتمد على الأنسولين):

- **نقصان مطلق** للأنسولين بسبب تخرب خلايا بيتا في البنكرياس، يصيب الأطفال والشباب ويعالج بإعطاء الأنسولين.
- المصاب يكون نحيل لأن الجسم يلجأ لبروتينات عضلاته وشحومه المخزّنة لإنتاج الطاقة في غياب الغلوكوز من الخلايا.

2. سكري نمط 2 (غير معتمد على الأنسولين):

- ينجم عن **اجتماع** مقاومة الأنسولين وخلل في خلايا بيتا، يصيب الكهول غالباً ويعالج بخافضات السكر الفموية.
- يعاني المصاب بدانة على عكس النمط الأول.

3. سكري حملي.

4. سكري ثانوي:

- يحدث بسبب:
  - أدوية: ثيازيد، ستيروئيدات سكرية.
  - بعض الأمراض الغدية: كوشينغ، ضخامة نهايات.
  - أمراض البنكرياس.
  - أمراض وراثيّة تصيب مستقبلات الأنسولين.

فحص المريض:

1. الحالة العامة:

- نبحث عن علامات **التجفاف** (بسبب البوال المتكرر).
- **البدانة**: في النمط الثاني من السكري.
- **علامات نقصان وزن جديدة** في داء السكري غير المضبوط.
- **علامات السكّري الثانوي**: كملامح الوجه المميزة في داء كوشينغ وضخامة النهايات وفرط التصبّغ في الصِّباغ الدموي.
- **تنفس كوسماول**: رائحة الفم المميزة لمريض السكري في حال وجود حماض كيتوني سكري.
- **حالة سبات**: بسبب التجفاف أو الاحماض أو فرط الأسمولية.

2. الأطراف السفلية:

- بعكس الأمراض الأخرى يفضّل البدء بالفحص السريري بالأطراف السفلية حيث توجد الكثير من العلامات السريرية:

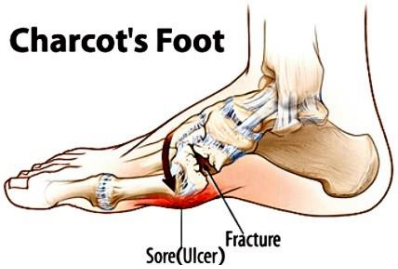


- الجلد في الأقدام والساقين بدون أشعار وضامر.
  - بسبب إصابة الأوعية الدقيقة وما تؤدّي إليه من نقص التروية.
- نبحث عن التقرّحات لاسيما في الإبهام أو أي منطقة من القدم معرضة للضغط.
  - تنجم التقرحات عن قصور في التروية بالإضافة إلى اعتلال عصبي محيطي.
- ندب مصطبغة.
- إنتانات جلدية مثل الدمامل والإنتانات الفطرية، وهي شائعة في السكري.
  - سببها توفر الوسط المناسب لنمو عناصر الإنتان بسبب النسبة العالية للسكر في الدم.

القدم السكرية



- نخر شحمي سكري.
- مناطق ضمور أو ضخامة.
  - بسبب حقن الأنسولين فيها.
- ضمور في العضلة رباعية الرؤوس الفخذية.
  - بسبب إصابة العصب الفخذي وتسمى خطأ الضمور العضلي السكري.
- مفصل شاركوت (نادر):
  - تشوه مفصلي بسبب الإصابات المتكررة واستعمال المفصل بعد الإصابات بسبب عدم الشعور بالألم.



- جس النبض المحيطي وحرارة القدم لأن غياب النبض المحيطي مع أقدام باردة يشير إلى إصابة وعائية محيطية.
- افحص المنعكسات العصبية في الأطراف السفلية.

الندب المصطبغة:

RBO Clinical IMP

- آفة جلدية وصفية لمرض السكري لكنها نادرة.
- وهي منطقة صفراء مندّبة (لويحات مدورة وصغيرة) تتوضع في قصبة الساق محاطة بحواف حمراء عندما تكون فعّالة.

3. الأطراف العلوية:

- نفحص:
  - **الأظافر** لتحري الالتهاب الفطري بالمبيضات.
  - **أماكن حقن الأنسولين** وتحري الضخامة أو الضمور.
  - **الضغط الشرياني** في وضعيات الوقوف والاستلقاء والجلوس لأن اعتلال الأعصاب في السكري يؤدي إلى انخفاض ضغط انتصابي.

4. الوجه:

1. العينان:



- **اضطرابات البصر**: قد تكون **دائمة** بسبب أذيات بالشبكية أو **مؤقتة** بسبب تغيرات العدسة الناجمة عن فرط سكر الدم واحتباس الماء.
- IMP **علامة أرغايل روبرتسون**: علامة **نادرة** في مرض السكري، نشاهد فيها حدقتين صغيرتين غير متساويتين ترتكسان إلى المطابقة لكن لا ترتكسان إلى الضوء.
  - أي تتقبضان عند تقريب جسم من العين لكنهما لا تتقبضان عند تسليط ضوء عليهما.
- **احمرار القزحية** قد يؤدي إلى زرق.
- **الساد**: يتحول السكر عند ارتفاع كثافته إلى سوربيتول في العدسة فيتراكم مسبباً ساد.
- **تغيرات الشبكية**:

نشاهد في الصورة المرفقة علامة أرغايل روبرتسون

A. **تكاثرية**: تنجم عن **نقص تروية شديد جداً**، تتطور (تتكاثر) أوعية دموية جديدة قد تؤدي إلى نزوف أو انفصالات بالشبكية.

B. **لا تكاثرية**: تنجم عن **نقص تروية أقل شدة** تشمل:

- نزوف نقطية، نزوف لطخية، آفات دم دقيقة (أمهات الدم) سببها أذيات في جدار الأوعية، نتحات صفراء اللون واضحة الحدود، تورمات بيضاء أشبه بمنظر القطن أو الصوف (دعيت سابقاً بالنتحات الطرية وتبيّن أنها تسمية خاطئة لأنها عبارة عن مناطق احتشاءات موضعية).

- نفحص وظيفة **الأعصاب 3،4،6** بحركات العين، خاصة العصب الثالث.

2. الفم:

- تحري وجود إنتان فطري (مبيضات)[2].

3. الأذن:

- **تحري وجود الإنتانات**: التهاب الأذن الخارجية الخبيث ناجم عن العصيات الزرق وهو نادر يسبب شلل العصب الوجهي في 50٪ من الحالات.

4. العنق والكتف:

- نفحص **الشريان السباتي** متحرّياً عن مرض وعائي.
- **الشواك الأسود**.

5. البطن:

- **ضخامة كبدية** واردة قد تنجم عن ارتشاح شحمي أو ارتكاس صباغي دموي (تراكم صباغي).

ملاحظات هامة:

- تعرّض القدم السكرية للإنتان (نتيجة أي جرح بسيط) هو **أمر خطير جداً** إذ قد يتسبب ببتر الساق في حال انتشاره، لذلك من الضروري جداً تنبيه مريض السكري إلى أهمية العناية بالقدم.
- **من أهم قواعد العناية بالقدم السكرية**: عدم قص الدمامل، تجنب جرح القدم قدر الإمكان، تنشيف القدم جيداً بعد الغسل تجنباً للإنتانات الفطرية.
- في كل زيارة يجب فحص قدم مريض السكري كما ذكرنا في الفحص السريري، كما يجب فحص قعر العين والبول والراسب كل سنة.
- يجب تنبيه المريض إلى أهمية الالتزام بأدويته خاصةً **أدوية الضغط** لأن اضطراب الضغط يضاعف أعراض المريض.



[2] داء المبيضات الفموي هي حالة تتراكم فيها فطريات المبيضات البيضاء على بطانة الفم.

البدانة Obesity

- البدانة أمر **نسبي** يختلف باختلاف طول الجسم.
- معظم الأشخاص البدينين لا يدركون المقدار الكبير الذي يتناولونه من الطعام، لذلك عندما يسألهم الطبيب عن الإفراط في تناول الطعام يجيبون بالنفي.
- مشعر كتلة الجسم Body Mass Index BMI = الوزن (كغ) \ مربع الطول (م).
- الجدول التالي يبين دلالات مشعر كتلة الجسم[3]:

Classification	BMI (Kg\m²)
Underweight	<18.5
Normal weight	18.5-24.9
Overweight	25-29.9
Obesity class1	30-34.9
Obesity class2	35-39.9
Extreme obesity class3	>40

مفارقات:

- البدانة الطبيعية تشمل كل الجسم بينما بدانة كوشينغ هي بدانة جذعية مع أطراف نحيلة.
- بدانة قصور الدرق معممة ترافق مع جلد متوزم.



مبارك وصولكم لنهاية المحاضرة يا أبطال

[3] المشعر ليس دقيق بما يكفي لأن الوزن يختلف بحسب توزع المواد في الجسم.

دوّن ملاحظاتك

- لا تنسونا من صالح الدعاء –